

SUPUESTO PRÁCTICO N° 1 PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ENFERMERA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL NÚMERO 233, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023.

Me llamo Fernanda y ya tengo 89 años, los cumplí en abril. Soy hija única, mis padres me criaron en un entorno tranquilo y me dieron muy buena educación para mi época, pues estuve estudiando interna en un colegio religioso de mi ciudad natal.

Me casé joven, como por entonces se hacía y llegamos a celebrar nuestras bodas de oro. No tuvimos hijos, pero si sobrinos por parte de las hermanas de mi marido. Él era el único varón, tenía tres hermanas. Así que estaba acostumbrado a no hacer nada en casa, ni pelarse la fruta, sin embargo en su trabajo fue muy buen profesional. ¡Lo que son las cosas!

Enviudé hace 8 años y desde entonces he vivido en mi casa acompañada por empleadas del hogar tanto de día como de noche.

Hasta que en los últimos meses mi salud empeoró y mis sobrinos han decidido traerme a un centro residencial, en el cual me proporcionan mayores cuidados y el entorno está más adaptado a mis necesidades.

Tengo glaucoma en ambos ojos y me ha ocasionado la pérdida de visión del ojo izquierdo. Me aplico los colirios que me recetó el especialista.

Comencé a tener trastornos gastrointestinales (diarreas) a las que en principio no hacía mucho caso y las trataba “como toda la vida: tomando una poquita manzanilla, yogurt natural y manzana asada”. Pero en cuanto un día no tenía deposiciones, comía lo que me apetecía y volvían las mismas. Después de llevar un mes así, el médico me diagnosticó diarrea infecciosa, para la cual me puso tratamiento ¡con antibiótico y todo! A consecuencia de las diarreas sufrí deshidratación ya que para mí tomar 2 vasos de agua (manzanilla o cualquier liquido) es “beberme el mar”. Me ingresaron en el hospital, pues presentaba, además, desorientación, fiebre e inapetencia. Entonces me diagnosticaron Deterioro Cognitivo Moderado (no tipo Alzheimer). Ya notaban mis sobrinos y las personas que me cuidaban que necesitaba ayuda para determinadas AIVD.

En casa he tenido varias caídas. Creo que alguna fue debida a que no llegué a tiempo al servicio y se me escapó la orina. En la última sufrí una Fractura de Rama Isquiopubiana Derecha, necesitando al alta de este nuevo ingreso hospitalario ayuda para todas las ABVD. Estoy en tratamiento con heparina (mientras dure el reposo en cama) y analgésicos.

Me gusta comer de todo y cualquier textura pero poquita cantidad. Aún tengo mi dentadura. No soy alérgica a nada, ni alimentos ni medicamentos. Ah! ¡Soy muy presumida! Me gusta estar bien arreglada, peinada de peluquería, maquillada, con mis joyas. Uso vestidos con combinación, medias, rebecas a juego con los vestidos.

1. A Fernanda, en su residencia, se le va a realizar una Valoración Geriátrica Integral. ¿Qué características deben tener las escalas utilizadas en la Valoración Geriátrica Integral?

- a) Deben ser subjetivas y flexibles para adaptarse a cada persona.
- b) Deben ser generales y no enfocadas en áreas específicas.
- c) Deben ser estandarizadas y ayudar a valorar la situación clínica de la persona de forma precisa.

2. ¿Qué cuestionario utilizaríamos si quisiéramos evaluarle las AIVD?

- a) Escala de Tinetti.
- b) Índice de Katz.
- c) Escala de Lawton y Brody.

3. ¿Qué cuestionario utilizaríamos si quisiéramos evaluarle el riesgo de caídas?

- a) Escala de Downton.
- b) Escala de Wells.
- c) Escala de Karfnski.

4. La movilidad de Fernanda está limitada. Para la prevención de las úlceras por presión, entre las intervenciones recomendadas a continuación, señale la incorrecta.

- a) Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo, realizando masaje vigoroso en las prominencias óseas.
- b) Los pacientes sentados deberán poner los pies sobre un reposapiés si estos no llegan al suelo.
- c) Lavar la piel con agua y jabón neutro, aclarar y secar cuidadosamente por empapamiento los pliegues cutáneos.

5. Fernanda presenta una herida en la piel, en la zona sacra con pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis y dermis, de unos 3 centímetros de diámetro. ¿En qué estadio está clasificada esta lesión o úlcera por presión (GNEAUPP)?.

- a) Estadio III.
- b) Estadio II.
- c) Estadio I.

6. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se encuentra en el primer escalón analgésico de la OMS?

- a) Paracetamol.
- b) Metamizol.
- c) Codeína.

7. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre los diagnósticos de enfermería: dolor agudo y dolor crónico?

- a) La intensidad del dolor.
- b) La duración del dolor: mayor o menor de 3 meses.
- c) El inicio del dolor: súbito o lento.

8. Si se necesitase administrarle medicamentos por vía intradérmica. Indique lo que no corresponda:

- a) La absorción es rápida.
- b) Se forma una pápula intracutánea o intradérmica.
- c) Sólo admite pequeños volúmenes.

9. Cuando hablamos de las etapas del Proceso de Enfermería, es FALSO que:

- a) En la etapa de Ejecución se llevan a cabo las intervenciones y se vuelve a valorar para determinar la respuesta de la persona.
- b) En la etapa de Planificación se recogen los datos sobre el estado de salud.
- c) La etapa de Evaluación mide si la persona ha logrado los resultados esperados.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la fragilidad no es cierta?

- a) Se puede prevenir, identificar y revertir.
- b) Se centra en el diagnóstico de las enfermedades y la adherencia a los tratamientos.
- c) Es el mejor predictor de eventos adversos y discapacidad.

11. Cuando Fernanda enviudó sufrió un proceso de duelo. ¿Cuánto tiempo se estima que puede durar un proceso de duelo normal?

- a) La duración depende exclusivamente del tipo de relación mantenida con la persona fallecida. No es igual la duración del duelo por un hijo, que por una madre anciana.
- b) La pérdida de un ser querido es un proceso que nunca tiene final y dura toda la vida.
- c) No se puede decir que el duelo se mantiene un tiempo determinado, porque su duración puede ser muy variable. Aun así, podemos considerar que los dos primeros años son los más duros.

12. Fernanda, aunque come de todo, come poca cantidad. Atendiendo al IMC (índice de masa corporal), entendemos que una persona adulta tiene normopeso:

- a) Cuando su IMC está entre 17 y 20,9 Kg/m².
- b) Cuando su IMC está entre 18,5 y 24,9 Kg/m².
- c) Cuando su IMC está entre 20 y 26,9 Kg/m².

13. Durante la higiene de Fernanda., ¿cómo promoveremos su independencia?

- a) Le pediremos que no se mueva mientras nosotros realizamos el proceso.
- b) Teniendo en cuenta sus limitaciones, le daremos una esponja para que ella misma se enjabone, participando activamente en el proceso.
- c) Ya que Fernanda vive en nuestro centro residencial, le instaremos a que no se mueva y se deje hacer todo por el personal para que no empeore su situación.

14. En la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se definen las Instrucciones Previas como:

- a) El documento en el que cualquier persona, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.
- b) El documento en el que el representante legal de una persona mayor de edad, incapacitada, manifiesta la voluntad de ésta, con objeto de que ésta se cumpla en circunstancias especiales, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino del cuerpo o de los órganos del mismo.
- c) El documento en el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

15. En relación con los efectos que produce la edad sobre la marcha y la mecánica al andar, señale la respuesta correcta:

- a) Aumento del balanceo de los brazos.
- b) Mayor rotación de la cadera.
- c) Disminución de la longitud de la zancada.

16. Fernanda, según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, Artículo 11, tiene derecho como persona usuaria de un Centro Residencial a:

- a) A mantener relación con el entorno familiar y social respetando lo previsto en las Normas que regulen el régimen de salidas y vistas del Centro.
- b) A recibir una atención personalizada de acuerdo con las condiciones que establezcan las Normas de Régimen Interno del Centro.
- c) A la personalización del entorno, dentro de su espacio privado en el centro, con respeto a lo previsto en el reglamento de régimen interno del mismo.

17. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 25 sobre el Servicio de Atención Residencial

- a) El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.
- b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.
- c) La atención Residencial a personas en situación de dependencia estará limitada por la organización del Centro residencial.

18. Andalucía dispone de una Estrategia de Coordinación Sociosanitaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó la I Estrategia de coordinación Sociosanitaria de Andalucía 2023-2026.
- b) Andalucía no dispone aún de estrategia de Coordinación Sociosanitaria, hay una propuesta inicial que se elabora en el seno de una Comisión de trabajo.
- c) Una de sus Líneas estrategias es: Definir la actuación de los servicios sociales y sanitarios en las unidades y centros de cuidados intermedios.

19. En la Residencia donde vive Fernanda se tiene un especial interés en corregir los sesgos cognitivos relacionados con el género ¿Cuál es un ejemplo de sesgo cognitivo en la atención residencial?

- a) Creer que las mujeres son más emocionales que los hombres y tomar decisiones sobre su atención basadas en este prejuicio.
- b) Tratar a todas las personas residentes por igual, sin tener en cuenta su género.
- c) Seguir estrictamente protocolos médicos sin considerar el género de la persona.

20. En una residencia, los delegados de prevención contemplados en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son:

- a) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
- b) Los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
- c) Los responsables de la evacuación del centro cuando se active el plan de prevención.

21. En la residencia donde vive Fernanda se trabaja en Equipo desde un enfoque donde el trabajo de las distintas disciplinas colaboran de manera integral, trascendiendo los límites de sus áreas específicas para abordar problemas complejos de forma holística. Esta metodología de Trabajo en Equipo se denomina:

- a) Equipo Interdisciplinar.
- b) Equipos de Interdependencia Social.
- c) Equipo Transdisciplinar.

22. Según la Ética del cuidado, ¿Qué se entiende por principio de justicia en la atención Residencial?

- a) Ofrecer la misma atención a todos los residentes, sin tener en cuenta sus diferencias individuales
- b) Tratar a todos los residentes de manera equitativa, reconociendo sus necesidades y proporcionando recursos según lo requieran.
- c) Evitar causar daño o sufrimiento innecesario a las personas residentes que reciben atención, ya sea de forma física, emocional o psicológica.

23. Fernanda vive en la Unidad de Convivencia “Roble” de su Residencia. Su Coordinadora de Unidad se llama Pepa. Como Coordinadora de Unidad, ¿Cuál de las siguientes no sería una función de Pepa?

- a) Motivar y reforzar al equipo en sus prácticas centradas en la persona.
- b) Facilitar la realización de actividades cotidianas con sentido.
- c) Determinar los objetivos del Plan de Atención Individualizada de Fernanda.

24. La residencia en la que vive Fernanda desea desarrollar un modelo de cuidados de larga duración de acuerdo al Modelo de Atención Centrado en la Persona. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes tres herramientas clave:

- a) Historia de vida, cómo quiero, proyecto de vida.
- b) Historia de vida, genograma familiar y mapa de preferencias.
- c) Proyecto de vida, mapa emocional y recursos y dificultades.

25. Informar y preguntar, las preferencias en la vida cotidiana, elecciones y percepción de control y planificación anticipada de decisiones son elementos de buena praxis en relación con:

- a) La intimidad
- b) La comunicación
- c) La autodeterminación

26. Fernanda disfruta mucho contando historias de su vida al personal de enfermería. Para hacer que Fernanda se sienta escuchada, éste personal practica la escucha activa en su relación con los residentes. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento clave en la escucha activa?

- a) Mirar a los ojos del interlocutor.
- b) Tocar las manos del interlocutor.
- c) Parafrasear.

27. De acuerdo con las competencias de enfermería en materia de Educación para la Salud, el equipo de enfermería de la residencia desea mejorar los hábitos de higiene buco-dental de las personas residentes. Este objetivo es el más básico y concreto dentro de la planificación en materia de Salud y Cuidados de la Residencia, por lo tanto, han de desarrollarlo a través de un:

- a) Programa.
- b) Proyecto.
- c) Plan.

28. Fernanda plantea al equipo de enfermería una propuesta de cuidados hacia su persona que les genera un dilema ético. Si aplicaran el método deliberativo para buscar un curso óptimo de acción ante este dilema, ¿a qué tres pruebas de consistencia deberían someter el curso elegido?

- a) Prueba de la legalidad, prueba de la publicidad y prueba del tiempo.
- b) Prueba de homogeneidad, prueba de la justicia y prueba de la seguridad.
- c) Prueba de la evidencia, prueba de la eficacia y prueba de la eficiencia

29. ¿Qué escala utilizarías para la valoración funcional de una persona mayor?

- a) Índice de Barthel.
- b) Escala Emina.
- c) Test del Reloj.

30. La Valoración Geriátrica Integral (VGI) consiste en un proceso:

- a) Dinámico, con carácter multidisciplinar y prolongado en el tiempo.
- b) Estático, hecho por el equipo de geriatría en un momento inicial.
- c) Dinámico, con carácter multidisciplinar, solo al inicio del proceso.

31. Elige el tipo de Incontinencia que más se ajuste a la siguiente definición: “Secundaria a problemas de movilidad de la persona o a factores ambientales. No existe defecto del tracto urinario; la incontinencia se debe a trastornos de la movilidad o estados confusionales”.

- a) Funcional
- b) De estrés.
- c) Por rebosamiento.

32. ¿Cómo se les denomina a los fármacos que se utilizan asociados junto a los que forman parte de la escalera analgésica de la OMS?

- a) Antagonistas.
- b) Coadyuvantes.
- c) Excipientes.

33. Señales las etapas correctas del Proceso Enfermero:

- a) Planificación, diagnóstico y ejecución.
- b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
- c) Diagnóstico, ejecución, evaluación y estandarización de los cuidados.

34. La rama de la Farmacología que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, y sus mecanismos de acción para efectuarlos, se denomina:

- a) Farmacocinética.
- b) Farmacodinamia o Farmacodinámica.
- c) Farmacoterapia.

35. El deterioro cognitivo puede manifestarse de diversas maneras y los síntomas pueden variar de una persona a otra. Algunos de estos síntomas comunes incluyen (señale la incorrecta):

- a) Dificultad para recordar información.
- b) Problemas para prestar atención y dificultad en el lenguaje.
- c) No hay dificultad para tomar decisiones.

36. Para procurar que no ocurran alteraciones de conducta se recomienda:

- a) Favorecer situaciones de bienestar, facilitar un entorno comprensible y una buena comunicación.
- b) Sobre estimular a la persona para que tenga todo el tiempo ocupado y no descansa.
- c) Interrumpirla constantemente.

37. ¿Qué recomendaciones le darías a Fernanda para evitar el estreñimiento? Señala la respuesta incorrecta:

- a) Ingesta de alimentos ricos en fibra, como fruta, verduras, cereales integrales, etc.
- b) Ingesta hídrica siempre que no exista una contraindicación.
- c) Tomar agua con limón en ayunas endulzada con miel.

38. ¿Cuáles son las complicaciones que puede sufrir Fernanda debido a su fractura? (señale la incorrecta)

- a) Úlceras por presión.
- b) Trombosis Venosa profunda.
- c) Diabetes.

39. Entre los accidentes que más se producen en las personas mayores se encuentran:

- a) Quemaduras por insensibilidad.
- b) Accidentes de tráfico como peatón.
- c) Caídas.

40. El principal indicador de deterioro neurológico es:

- a) La alteración del nivel de la capacidad de respuesta.
- b) La respuesta motora.
- c) Los signos vitales alterados.

PREGUNTAS DE RESERVA:

41. En las dimensiones de calidad asistencial, cuando hablamos de ofrecer la mayor cantidad posible de servicios de alta calidad, al menor coste posible, nos referimos a:

- a) Eficacia.
- b) Eficiencia.
- c) Efectividad.

42. Si en la residencia se produce un incendio de un colchón de una cama debido a que un residente se encuentra fumando, lo más adecuado es usar:

- a) Cualquier agente extintor para fuegos de clase A.
- b) Cualquier agente extintor para fuegos de clase B.
- c) Cualquier agente extintor para fuegos de clase C.

43. El Modelo de Atención Centrado en la Persona está estrechamente relacionado con el Modelo de Calidad de vida de R. Schalock y M.A. Verdugo. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento clave de este modelo?

- a) Bienestar material
- b) Desarrollo personal.
- c) Responsabilidad social.

44. La historia de vida:

- a) Permite un conocimiento superficial de la persona, a través de su historia personal.
- b) Nunca será relatada por sus familiares, amigos, vecinos...etc.
- c) Puede ser relatada por la propia persona, por sus familiares, amigos, vecinos...etc.

45. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos NANDA de incontinencia urinaria no existe?

- a) Incontinencia urinaria de esfuerzo.
- b) Incontinencia urinaria de por rebosamiento.
- c) Incontinencia urinaria del anciano.

ANUNCIO

EJERCICIO PRÁCTICO N° 1 PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ENFERMERA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOP N° 233 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANTILLA RESPUESTA

Pregunta N°	Respuesta correcta	Pregunta N°	Respuesta correcta
1	C	26	B
2	C	27	B
3	A	28	A
4	A	29	A
5	B	30	A
6	C	31	A
7	B	32	B
8	A	33	B
9	B	34	B
10	B	35	C
11	C	36	A
12	B	37	C
13	B	38	C
14	C	39	C
15	C	40	A
16	C	41	B
17	A	42	A
18	C	43	C
19	A	44	C
20	A	45	C
21	C		
22	B		
23	C		
24	A		
25	C		

SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ENFERMERA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL NÚMERO 233, DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023.

Me llamo Mariano, nací en Almería en 1966, tengo 58 años y estoy soltero. Mi familia era pequeña y humilde, tuvimos que emigrar a Madrid, para que mi padre pudiera trabajar. Allí estuve escolarizado y a los 16 años dejé los estudios, que nunca me gustaron, y comencé a trabajar en la hostelería. También comencé a fumar y a beber habitualmente. Regresé a Almería con 22 años, tras el servicio militar y continué trabajando en la hostelería y manteniendo esas costumbres tan poco saludables. También comencé a distanciarme de mi familia más inmediata con la que nunca me he llevado bien, mi padre ya había fallecido.

A los 35 años me dijo el médico que tenía Hipertensión Esencial y Diabetes Mellitus tipo 2, también una cosa que llamaba Hiperlipidemia, y que tenía que tomar medidas (comer mejor, hacer ejercicio, tomar pastillas y hacerme análisis) pero a mí se me olvidaba la mayoría de las veces... como no me dolía nada.

A los 50 años mi vida cambió radicalmente, sufrí un Accidente Cerebro Vascular Isquémico y como secuela me quedó una Hemiplejía Derecha y una Afasia. Desde entonces no puedo caminar y necesito una silla de ruedas. Tampoco puedo hablar, salvo algunas expresiones aisladas, pero comprendo todo lo que me dicen. En esa época, al ver que no me podía valer por mí mismo, mis primos (la única familia que ya me quedaba) decidieron ingresarme en una residencia. Yo apenas me pude oponer. Dos años más tarde por complicaciones circulatorias, sufrí una amputación supracondilea del miembro inferior derecho. También he desarrollado una retinopatía diabética y he perdido totalmente la visión en el ojo derecho por un glaucoma.

Llevo en esta residencia desde hace 8 años. En ella estoy bastante adaptado. Me suministran todas las medicinas que necesito, que son muchas, por lo que me dicen que estoy polimedicado, aunque me gustaría tomar menos.

Necesito apoyos extensos para el aseo y el baño, para vestirme y me gusta elegir mi ropa. Uso el WC con ayuda cuando lo pido, aunque ocasionalmente se me escapa la orina, sobre todo por las noches y si tardan mucho en llevarme al WC. No duermo muy bien, me despierto muchas veces y por eso me dan una pastilla todas las noches. Puedo comer solo, si me ayudan a partir la comida, y tomo dieta diabética hiposódica de fácil masticación porque he perdido varias piezas dentales. Todavía fumo y alguna copa de vino tomo en ocasiones.

No me gusta relacionarse con los demás, soy muy introvertido y dicen mis compañeros de la unidad de convivencia que poco sociable. Tampoco participo en las actividades que se programan en la residencia. Me gusta más estar a mi aire. Mantengo una mala relación con la familia, apenas me trato con mis primos, que ya no quieren saber nada de mí. Por eso estoy tutelado por una fundación de apoyos judiciales desde 2018.

1. Uno de los medicamentos que toma Mariano para la diabetes es la Metformina. ¿Cuál es la dosis máxima de Metformina que podría tomar?
 - a) Un comprimido de 850 mg al día.
 - b) Dos comprimidos de 850 mg al día.
 - c) Tres comprimidos de 850 mg al día.

2. Mariano es hipertenso. Se define la HTA como la elevación persistente de la presión arterial por encima de:
 - a) $> 140/90$.
 - b) $> 150/100$.
 - c) $> 160/100$.

3. El tipo de dolor que padece un paciente intervenido de amputación de un miembro, como es el caso de Mariano es:
 - a) Dolor nociceptivo.
 - b) Dolor neuropático.
 - c) A y B son correctas.

4. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se encuentra en el primer escalón analgésico de la OMS?
 - a) Paracetamol.
 - b) Metamizol.
 - c) Codeína.

5. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre los diagnósticos de enfermería: dolor agudo y dolor crónico?
 - a) La intensidad del dolor.
 - b) La duración del dolor: mayor o menor de 3 meses.
 - c) El inicio del dolor: súbito o lento.

6. Si se necesitase administrar medicamentos por vía intradérmica. Indique lo que no corresponda:
 - a) La absorción es rápida.
 - b) Se forma una pápula intracutánea o intradérmica.
 - c) Sólo admite pequeños volúmenes.

7. ¿Qué parámetros nutricionales básicos debemos conocer a través de prueba analítica para una correcta evaluación del estado nutricional de Mariano?

- a) Proteínas plasmáticas: albúmina y prealbúmina.
- b) Recuento de linfocitos.
- c) Todas son correctas.

8. ¿Qué es un factor de riesgo vascular (RV)?

- a) Es un factor que indica, la probabilidad de padecer o morir por una enfermedad del aparato circulatorio.
- b) Un factor genético intrínseco.
- c) Un factor genético extrínseco.

9. ¿Qué no es considerado factor de riesgo vascular?

- a) Tabaquismo.
- b) Sedentarismo.
- c) Antecedentes de enfermedad cardiovascular en familiares de 2º grado.

10. El índice tobillo brazo (ITB) se usa principalmente para:

- a) Estimar la gravedad de la enfermedad vascular periférica o para establecer los valores de referencia.
- b) Descartar trombosis en miembros inferiores.
- c) Saber la TA de la arteria pedía.

11. La cura seca está indicada en: (señale la incorrecta)

- a) En lesiones isquémicas no revascularizadas.
- b) En una lesión en pierna con presencia de pulsos distales.
- c) En la asistencia de heridas en primeros auxilios.

12. ¿Cuáles son signos clínicos de infección? (diga cuál es la incorrecta)

- a) Exudado seroso.
- b) Calor.
- c) Eritema.

13. Elige el tipo de incontinencia que más se ajuste a la siguiente definición: “Engloba las alteraciones de la dinámica miccional que se originan en el sistema nervioso. En su desarrollo influyen los ACV, la Esclerosis Múltiple, el Parkinson y las lesiones medulares. No hay deseo de orinar o de hacer fuerza antes de una micción involuntaria y periódica”.

- a) Por esfuerzo.
- b) Por sobreflujo o rebosamiento.
- c) Refleja/neurológica.

14. Señale las etapas correctas del Proceso Enfermero:

- a) Planificación, diagnóstico y ejecución.
- b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
- c) Diagnóstico, ejecución, evaluación y estandarización de los cuidados.

15. Se realiza una valoración de la polimedicación de Mariano, según los criterios STOPP/START. De las siguientes opciones, ¿cuál es correcta según estos criterios?

- a) Los criterios STOPP/START son un método de triage de catástrofes.
- b) Constan, en realidad, de dos grupos de criterios: los STOPP (“parar” o “detener”) y los START (“empezar”).
- c) No es necesario tener tiempo para realizarlo, Mariano no necesita valoración de la medicación ya que se la toma toda.

16. Entre las modificaciones del estilo de vida para el manejo de la HTA de Mariano, no se encuentra:

- a) Aumento de peso.
- b) Reducción de la ingesta de sodio.
- c) Moderación en el consumo del alcohol.

17. A la hora de comunicarnos con Mariano debido a su afasia, tendremos en cuenta los siguientes consejos (señale la respuesta incorrecta):

- a) Enfatiza los errores para que aprenda.
- b) Apoyar nuestras palabras con gestos.
- c) Hablar lentamente y sin gritar.

18. ¿Qué complicación aguda puede presentar Mariano si no se toma la medicación antidiabética durante mucho tiempo?

- a) Hipoglucemia.
- b) Coma hiperosmolar no cetosico.
- c) Acidosis láctica.

19. La historia de vida:

- a) Permite un conocimiento superficial de la persona, a través de su historia personal.
- b) Nunca será relatada por sus familiares, amigos, vecinos...etc.
- c) Puede ser relatada por la propia persona, por sus familiares, amigos, vecinos...etc.

20. ¿Qué recomendaciones le darías a Mariano para evitar el estreñimiento? Señala la respuesta incorrecta:

- a) Ingesta de alimentos ricos en fibra, como fruta, verduras, cereales integrales, etc.
- b) Ingesta hídrica siempre que no exista una contraindicación.
- c) Tomar agua con limón en ayunas endulzada con miel.

21. En la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se definen las Instrucciones Previas como:

- a) El documento en el que cualquier persona, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.
- b) El documento en el que el representante legal de una persona mayor de edad, incapacitada, manifiesta la voluntad de ésta, con objeto de que ésta se cumpla en circunstancias especiales, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino del cuerpo o de los órganos del mismo.
- c) El documento en el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

22. Mariano, según la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, Artículo 11, tiene derecho como persona usuaria de un Centro Residencial a:

- a) A mantener relación con el entorno familiar y social respetando lo previsto en las Normas que regulen el régimen de salidas y vistas del Centro.
- b) A recibir una atención personalizada de acuerdo con las condiciones que establezcan las Normas de Régimen Interno del Centro.
- c) A la personalización del entorno, dentro de su espacio privado en el centro, con respeto a lo previsto en el reglamento de régimen interno del mismo.

23. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su artículo 25 sobre el Servicio de Atención Residencial

- a) El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.
- b) Proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad.
- c) La atención Residencial a personas en situación de dependencia estará limitada por la organización del Centro residencial.

24. Andalucía dispone de una Estrategia de Coordinación Sociosanitaria, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó la I Estrategia de coordinación Sociosanitaria de Andalucía 2023-2026.
- b) Andalucía no dispone aún de estrategia de Coordinación Sociosanitaria, hay una propuesta inicial que se elabora en el seno de una Comisión de trabajo.
- c) Una de sus Líneas estrategias es: Definir la actuación de los servicios sociales y sanitarios en las unidades y centros de cuidados intermedios.

25. En la Residencia donde vive Mariano se tiene un especial interés en corregir los sesgos cognitivos relacionados con el género ¿Cuál es un ejemplo de sesgo cognitivo en la atención residencial?

- a) Creer que las mujeres son más emocionales que los hombres y tomar decisiones sobre su atención basadas en este prejuicio.
- b) Tratar a todas las personas residentes por igual, sin tener en cuenta su género.
- c) Seguir estrictamente protocolos médicos sin considerar el género de la persona.

26. En una residencia, los delegados de prevención contemplados en el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son:

- a) Los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
- b) Los técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
- c) Los responsables de la evacuación del centro cuando se active el plan de prevención.

27. En la residencia donde vive Mariano se trabaja en Equipo desde un enfoque donde el trabajo de las distintas disciplinas colaboran de manera integral, trascendiendo los límites de sus áreas específicas para abordar problemas complejos de forma holística. Esta metodología de Trabajo en Equipo se denomina:

- a) Equipo Interdisciplinar.
- b) Equipos de Interdependencia Social.
- c) Equipo Transdisciplinar.

28. Según la Ética del cuidado, ¿Qué se entiende por principio de justicia en la atención Residencial?

- a) Ofrecer la misma atención a todos los residentes, sin tener en cuenta sus diferencias individuales
- b) Tratar a todos los residentes de manera equitativa, reconociendo sus necesidades y proporcionando recursos según lo requieran.
- c) Evitar causar daño o sufrimiento innecesario a las personas residentes que reciben atención, ya sea de forma física, emocional o psicológica.

29. Mariano vive en la Unidad de Convivencia “León” de su Residencia. Su Coordinadora de Unidad se llama Luisa. Como Coordinadora de Unidad, ¿Cuál de las siguientes no sería una función de Luisa?

- a) Motivar y reforzar al equipo en sus prácticas centradas en la persona.
- b) Facilitar la realización de actividades cotidianas con sentido.
- c) Determinar los objetivos del Plan de Atención Individualizada de Mariano.

30. La residencia en la que vive Mariano desea desarrollar un modelo de cuidados de larga duración de acuerdo al Modelo de Atención Centrado en la Persona. Para ello, debe tener en cuenta las siguientes tres herramientas clave:

- a) Historia de vida, cómo quiero, proyecto de vida.
- b) Historia de vida, genograma familiar y mapa de preferencias.
- c) Proyecto de vida, mapa emocional y recursos y dificultades.

31. Informar y preguntar, las preferencias en la vida cotidiana, elecciones y percepción de control y planificación anticipada de decisiones son elementos de buena praxis en relación con:

- a) La intimidad
- b) La comunicación
- c) La autodeterminación

32. A Mariano le cuesta mucho contar historias de su vida al personal de enfermería. Para hacer que Mariano se sienta escuchado, éste personal practica la escucha activa en su relación con los residentes. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento clave en la escucha activa?

- a) Mirar a los ojos del interlocutor.
- b) Tocar las manos del interlocutor.
- c) Parafrasear.

33. De acuerdo con las competencias de enfermería en materia de Educación para la Salud, el equipo de enfermería de la residencia desea mejorar los hábitos de higiene buco-dental de las personas residentes. Este objetivo es el más básico y concreto dentro de la planificación en materia de Salud y Cuidados de la Residencia, por lo tanto, han de desarrollarlo a través de un:

- a) Programa.
- b) Proyecto.
- c) Plan.

34. Mariano plantea al equipo de enfermería una propuesta de cuidados hacia su persona que les genera un dilema ético. Si aplicaran el método deliberativo para buscar un curso óptimo de acción ante este dilema, ¿a qué tres pruebas de consistencia deberían someter el curso elegido?

- a) Prueba de la legalidad, prueba de la publicidad y prueba del tiempo.
- b) Prueba de homogeneidad, prueba de la justicia y prueba de la seguridad.
- c) Prueba de la evidencia, prueba de la eficacia y prueba de la eficiencia

35. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la cifra aconsejable de HbA1 glicosilada para el correcto control de la diabetes de Mariano?

- a) Menor del 6.5%.
- b) Menor del 7%.
- c) Menor del 7.5%.

36. Mariano es un residente polimedicado. La rama de la Farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo y que incluye su liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción es la:

- a) Farmacocinética.
- b) Farmacodinamia.
- c) Farmacoterapia.

37. Entre los riesgos más comunes para la seguridad y salud de los trabajadores sanitarios en el puesto de trabajo se encuentra el sobreesfuerzo. Señale cuál de las siguientes medidas no adoptaría para su prevención:

- a) En el caso de participar en la movilización de un paciente, y cuándo éste no colabore, utilizar medios mecánicos como grúas.
- b) La manipulación manual de cargas se realizará transportando el mayor peso posible, manteniendo la espalda recta y la carga lejos del cuerpo, sin realizar giros del tronco. Utilizar la fuerza de las piernas flexionando las rodillas.
- c) Cuando no sea posible el uso de medios mecánicos, se requerirá la colaboración de otros trabajadores, y se coordinarán los movimientos al unísono.

38. La movilidad de Mariano está limitada. Para la prevención de las úlceras por presión, entre las intervenciones recomendadas a continuación, señale la incorrecta.

- a) Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo, realizando masaje vigoroso en las prominencias óseas.
- b) Los pacientes sentados deberán poner los pies sobre un reposapiés si estos no llegan al suelo.
- c) Lavar la piel con agua y jabón neutro, aclarar y secar cuidadosamente por empapamiento los pliegues cutáneos.

39. Mariano presenta una úlcera en el pie izquierdo, en la zona del 5º metatarsiano, de unos tres centímetros de diámetro. ¿Cuál de las siguientes características de la úlcera de pie diabético no corresponde a una etiología neuropática?

- a) Pulso ausente y temperatura fría.
- b) Se presenta en zonas que soportan el peso del pie, cabezas metatarsianas, talón o sobre el dorso de los dedos en garra.
- c) La zona presenta pérdida sensorial.

40. La residencia en la que se encuentra Mariano cuenta con la acreditación de calidad de la ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía). En función del resultado de la evaluación realizada en los centros sociosanitarios, la ACSA otorga su sello de calidad en tres niveles progresivos ¿cuáles son?

- a) Avanzado, experto y excelente.
- b) Avanzado, óptimo o excelente.
- c) Óptimo, experto y excelente.

PREGUNTAS DE RESERVA:

41. Mariano tiene reconocido un grado II en su valoración de dependencia. Según la ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia este grado significa:

- a) Dependencia moderada.
- b) Dependencia severa.
- c) Gran dependencia.

42. Los médicos hablan de Glucemia Basal Alterada (GBA) cuando las personas que aun no son diabéticas tienen valores de:

- a) Glucemia en ayunas entre 90 y 126 mg/dl.
- b) Glucemia en ayunas entre 110 y 125 mg/dl.
- c) Glucemia al azar entre 120 y 150 mg/dl.

43. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. ¿Cuánto tiempo se deben conservar los datos de los pacientes?:

- a) Indefinidamente.
- b) Al menos 5 años.
- c) Durante un año.

44. En la historia de vida de Mariano encontramos acontecimientos vitales traumáticos ¿Cuáles son factores de riesgo del duelo patológico?

- a) Alteración en el patrón del sueño, sufrimiento.
- b) Alteración del nivel de actividad, desorganización, experimentación de alivio.
- c) Problemas de salud mental previos, muerte múltiple, relación previa conflictiva.

45. En las dimensiones de calidad asistencial, cuando hablamos de ofrecer la mayor cantidad posible de servicios de alta calidad, al menor coste posible, nos referimos a:

- a) Eficacia.
- b) Eficiencia.
- c) Efectividad.

ANUNCIO

EJERCICIO PRÁCTICO N° 2 PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO A.2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE MEDIA, DENOMINACIÓN ENFERMERA/O, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, CUYAS BASES FUERON PUBLICADAS EN EL BOP N° 233 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2023

PLANTILLA RESPUESTA

Pregunta N°	Respuesta correcta	Pregunta N°	Respuesta correcta
1	C	26	A
2	A	27	C
3	C	28	B
4	C	29	C
5	B	30	A
6	A	31	C
7	C	32	B
8	A	33	B
9	C	34	A
10	A	35	B
11	B	36	A
12	A	37	B
13	C	38	A
14	B	39	A
15	B	40	B
16	A	41	B
17	A	42	B
18	B	43	B
19	C	44	C
20	C	45	B
21	C		
22	C		
23	A		
24	C		
25	A		

A